

Pikaajalise hoolduse olukord Eestis ja riigi väljakutsed omastehooldajate koormuse vähendamisel

Ülevaate Maailmapanga uuringu „Hoolduskoormuse vähendamine Eestis” ja hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma lõppraporti põhjal on koostanud **Anniki Lai** (hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma juht aastatel 2016–2017).

2015. aasta detsembris moodustati valitsuse otsusega Riigikantselei juurde hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm¹, kelle ülesandeks sai kahe aasta jooksul välja selgitada probleemid pikaajalises hoolduses ning koostada suunised ja lahendused olukorra parandamiseks. Rakkerühma tegevust rahastati ühtekuuluvusfondide 2014–2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus” meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine”.

Rakkerühm otsustas tellida Riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi rahastusel Maailmapangalt mahuka uuringu, et saada üksikasjalik ülevaade olukorrast, mille alusel välja töötada täpsemad poliitikasuunised. Seega tegutses rakkerühm suure osa oma tegevusperioodist uuringu juhtrühmana, et tagada selle asjakohasus.

2017. a juunis valminud Maailmapanga uuring „Hoolduskoormuse vähendamine Eestis” kaardistas praeguse olukorra, prognoosis hooldusvajaduse muutumist ajas tulevalt rahvastikuprotsessidest ja rahvastiku tervise trendidest koos nende võimalike majanduslike mõjudega ning analüüsis sot-

siaal- ja tervishoiuvaldkonna koostoimet. Uurimistulemustele tuginedes antakse poliitikasoovitusi tervikliku süsteemi arendamiseks pikaajalises hoolduses. Käesolevas artiklis esitatakse kokkuvõte Maailmapanga uuringu tulemustest.

Metoodika lühikirjeldus

Uuring korraldati kolmes etapis. Esimeses etapis koostati ülevaade hoolduskoormuse olukorrast Eestis, tuginedes kirjandusele, olemasolevatele materjalidele ning saadaolevate andmete analüüsile. Teises etapis koostati projektsioonid hooldusvajadusest ja selle võimalikest majandusmõjudest aastani 2030. Lisaks kaardistati parimaid rahvusvahelisi praktikaid, et leida Eestile sobivaid hoolduskoormuse vähendamise meetmeid. Uuringu kolmandas etapis koostati neli võimalikku stsenaariumi liikumisel praeguselt olukorralt hoolduskoormuse maksimaalse vähendamise poole, tuginedes uuringu varasemates etappides kogutud andmetele.

Pikaajalise hoolduse mõiste

Eesti õigusruumis puudub pikaajalise

¹ Rakkerühma ja selle liikmete kohta leiab infot <https://riigikantselei.ee/et/hoolduskoormus>.

hoolduse mõiste ühtne definitsioon ning Maailmapank² on soovitanud selle selgelt määratleda. Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm soovib oma lõppraportis kasutada Maailmapanga välja pakutud ja rakkerühma poolt täiendatud määratlust, mis on sõnastatud järgmiselt: „Pikaajaline hooldus on hooldus inimestele, kes vajavad abi argielu korraldamisel **pikema aja jooksul**, kuna nende füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud. Pikaajaline hooldus hõlmab tervishoiuteenuseid, isikuhooldust ja inimese igapäevast toimetulekut toetavaid teenuseid, mida pakutakse selleks, et:

- leevendada ja vähendada valu, juhtida tervises seisundi kulgu, vältida ja pidurdada selle halvenemist
- pakkuda isikuhooldust igapäevastes tegevustes, nagu söömine, pesemine, riietumine jm
- abistada iseseisva toimetuleku võimaldamiseks igapäevaste toimingute juures, nagu toidu valmistamine, poes käimine, olmega seotud rahaasjade korraldamine jm.”

Praegune olukord

Euroopa Liidu riikide andmete analüüsi põhjal selgus, et **Eesti elanikkond vananeb kiiresti ja ebatervislikul viisil**, mis soodustab raskete tervisekahjustuste teket vanemaealiste hulgas. See aga tähendab, et tulevikus **suureneb nõudlus pikaajalise hoolduse teenuste järele** märkimisväärselt. Eesti üle 65 aastased inimesed vajavad oma ELi eakaaslastega võrreldes rohkem abi argitoimetustes, seisavad sagedamini silmitsi liikumispiirangutega ja neil on keskmisest suurem kehamassiindeks. Eesti sai kõigi vanusegruppide koondarvestuses (sh noored täiskasvanud ja lapsed) EL keskmisest halvema tulemuse selliste inimeste arvestuses, kel esines enda sõnul raskusi argitoimingute

sooritamisel ühes või mitmes valdkonnas. Seega ei vaja pikaajalist hooldust üksnes vanemaealised, teenuste vajajaid on kõigis vanusegruppides.

Hoolimata kasvavast nõudlusest **rahastab Eesti avalik sektor pikaajalist hooldust väiksemas ulatuses** kui teised EL liikmesriigid, mistõttu tuleb inimestel sageli tasuda hoolduse eest omast taskust. Eesti kulutas 2013. aastal pikaajalisele hooldusele ligikaudu 0,6 protsendipunkti SKPst; võrdluseks moodustas pikaajalise hoolduse riiklik rahastus Saksamaal, Austrias ja Luksemburgis 1,5% SKPst, Taanis ja Soomes 2,5% ning Rootsis, Madalmaades ja Norras üle 3,5%. Samas on järsult tõusnud inimeste kulutused. Kuigi omaosalusmaksete absoluutase on võrdlemisi madal, siis arvestades hooldusteenuste piiratud kättesaadavust ja seega nende kasutuse vähest mahtu, moodustab see üsna suure osa majapidamiste sissetulekutest. Seega sõltub ligipääs teenustele üha enam **teenusekasutaja maksevõimest**, mis suurendab teenuste kasutamisest tingitud **vaesumise riski**. Arvestades, et suure osa 50aastaste ja vanemate inimeste rahalised võimalused on piiratud, seab pikaajalise hoolduse teenustega adekvaatse kaetuse puudumine paljud Eesti vanemaealised suurde vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu. Üldiselt madalate sissetulekute tõttu on vaesusrisk ka teistel hooldusvajadusega rühmadel.

Avaliku sektori vähese rahastuse tõttu on teenustega kaetus ebapiisav ja eavõrdne. Tervishoiu on pikaajalises hoolduses puudus õendushoolduse voodikohtadest. Ligipääs õendusabi teenusele on piirkonniti ebahühtlane, mis on osaliselt tingitud koduõdede vähesusest. Näiteks Lääne-Viru maakonnas haigekassa ostetavad õendushoolduse teenused katavad 40% hinnangulisest teenusevajadusest, samas kui Põlva maa-

² Maailmapanga uuring „Hoolduskoormuse vähendamine Eestis” (2017)

konnas kaetakse hinnangulisest vajadusest 77%. Sotsiaalvaldkonnas sõltub pikaajalise hooldusega kaetus kohalike omavalitsuste võimekusest pakkuda sotsiaalseid hüvitisi ja teenuseid ning see oleneb suuresti eelarves selleks ette nähtud summadest. Kuigi kohalikud omavalitsused peavad pikaajalise hoolduse teenuseid pakkudes järgima seadustest tulenevaid kohustusi, on neil suur otsustusvõim ja autonoomia oma poliitika määratlemisel ning nende võimekus pakkuda ja rahastada teenuseid on väga ebavõrdne³.

Pikaajalise hoolduse teenuste ebapiisava kaetuse ning avaliku sektori vähesel rahastusel tõttu **langeb** mitteametlikele hooldajatele, st **omastehooldajatele ebaproportsionaalselt suur hoolduskoormus**, mis toob kaasa märkimisväärseid majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid. Eestis on hoolduskoormus ligikaudu 30 000 naisel ja 17 000 mehel.

Omastehooldus piirab pereliikmete (eriti naiste) võimet aktiivselt tööturul osaleda. Tööjõu-uuringu andmetel on omakse hooldamise tõttu tööturult eemal 8000 inimest ja 5000 töötab osajaga, mis tähendab riigi jaoks kaudseid kulusid, sest saamata jääb maksutulu ning kasvab surve niigi tööjõupuuduses vaevlevale tööturule. Lisaks majanduslikele kuludele kaasnevad omaste hooldamisega ka sotsiaalsed kulud, sh haige või puudega perekonnaliikme hooldamise psühhosotsiaalne mõju ning hooldaja enda tervise halvenemine.

Kuigi Eesti pikaajalise hoolduse korraldus sõltub suuresti mitteametlikust hooldusest, **ei pakuta omastehooldajatele piisavaid sotsiaalseid garantiisid**, hooldajatoetuse maksmise ebaühtlane praktika süvendab sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust veelgi. Vaesemad ja madalama haridustasemega puuetega inimesed sõltuvad suure tõenäo-

susega rohkem mitteametlikust hooldusest. Mitteametliku hoolduse pakkumise ja hooldajatoetuse maksmise kohta ei ole kehtestatud kohustuslikke miinimumnõudeid, mistõttu otsustavad kohalikud omavalitsused juhtumipõhiselt ise, kuidas toetust maksta; toetuse maksmises on piirkonniti väga suured erinevused. Hooldajatoetusele kulutatud raha elaniku kohta kõikus 2016. aastal 0,86 eurost Saaremaal 9,86 euronni Võrumaal (kümme korda suurem, kuid siiski väga madal).

Probleemid ei tulene ainult rahapuudusest või teenuste vähesusest, vaid pikaajalise hoolduse **ebaefektiivsest korraldusest**. Näiteks on hooldus- ja teenusvajaduste hindamise praktika eri asutustel ja valdkondades väga erinev ning puudub sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna ühine standardiseeritud hindamisraamistik. Samuti puudub üleriigiline andmekogumise ja monitooringu raamistik, mis võimaldaks analüüsida teenuste osutamise mahtu, teenuste pakkumist ning kvaliteeti. Sotsiaalteenuste andmeid hallatakse suurelt jaolt üksnes kohalike omavalitsuste tasandil ning suur osa sellest on paberipõhine.

Ebaefektiivsust süvendab **tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna lahusus**. Valdcondade erinev ja eraldatud rahastamine ning väga selgejooneline organisatsiooniline (asutuspõhine) ja professionaalne (ametialane) eraldatus ei innusta neid valdkondi omavalhel hooldust koordineerima ning teenuseid kooskõlastatult osutama. Valdcondade lahusus väljendub ka sarnase sisuga kodu- ja kogukonnateenuste (koduõendus ja isikuabi ning koduteenused) ning institutsionaalse hoolduse (üldhooldekodu ja õendushaigla) paralleelses pakkumises. Esmatasandi tervishoiusüsteem ei kooskõlasta keskselt inimeste liikumist tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vahel.

³ Kuigi sotsiaalhoolekande seadus seab omavalitsustele kohustuse pakkuda 11 sotsiaalteenust (millest mõned on ka pikaajalise hoolduse teenused), ei tee seda kõik omavalitsused ning teenuste standardid on väga üldised ja võimaldavad erinevaid tõlgendusi.

Vajadused ja kulutused tulevikus

Pikaajalise hoolduse kasvavad vajadused ja kulutused, mis on põhjustatud kiirest ja ebatervislikust vananemisest, avaldavad järgmise paari aastakümne jooksul märkimisväärset **survet avaliku sektori eelarvele**. Euroopa Komisjoni vananemise raporti (2015) hinnangul suurenevad Eesti kulutused pikaajalisele hooldusele aastatel 2013–2060 võrreldes praeguse kulutuste tasemega 0,6 kuni 1,3 protsenti SKPst, kui arvestada üksnes demograafilist mõju. Eesti elatustaseme ja teenuste katvusmäära lähenemine EL keskmisele võib aga 2060. aastaks Eesti pikaajalise hoolduse kulutusi suurendada lausa 4 protsendini SKPst.

Õigluse ja võrdsuse seisukohalt lähtudes on **vähe võimalusi rahastada pikaajalise hoolduse teenuseid täiendavalt sotsiaalkindlustuse ja palgafondi maksudest**. Sotsiaalkindlustuse ja palgafondi maksud moodustavad juba praegu märkimisväärse osa valitsuse tuludest. Kuigi maksud on viimastel aastatel vähenenud, tekitab muret tööjõumaksude suhteliselt kõrge tase. Veel üks murekoht on sissetulekute ebavõrdsuse kasv Eestis. Eestis on toimetuleku- ja sotsiaaltoetused võrreldes paljude teiste EL riikidega toonud kaasa palju vähem võrdsust. Praeguse maksusüsteemi juures ei ole soovitatav pikaajalise hoolduse rahastamiseks osamakselise riikliku hoolduskindlustuse kehtestamise teel sotsiaalmakse suurendada. Seega peaks rahastus avaliku sektori poolt hooldusteenuste paremaks pakkumiseks tulema teistest tuluallikatest.

Poliitikavalikud ja -soovitused

Maailmapank soovib Eestil pikaajalise hoolduse korralduse reformimisel liikuda sammhaaval olemasolevast olukorrast ehk

nullpunktist järjest parema süsteemi suunas ning pakub selleks välja kolm etappi (vt tabel 1). Poliitikakujunduse etapid hõlmavad kaht liiki sekkumisi, mis on vajalikud Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi arendamiseks: tegelemine kiireloomuliste poliitiliste prioriteetidega ja nn ideaalse süsteemi poole liikumiseks vajalike ehitusplokkide tugevdamine.

Kiireloomuliste prioriteetidena soovib Maailmapank tegeleda ebavõrdsusega teenuse osutamisel. Selleks tuleks pikaajalise hoolduse täiendaval rahastamisel keskenduda nendele kohalikele omavalitsustele, kelle võime teenuseid rahastada on nõrgem, ning suurendada omastehooldajatele võimaldatavat rahalist ja sotsiaalset toetust. **Ehitusplokkide** hulka kuuluvad riigi juhtimisfunktsioon, õigusruum, asutused ja mehhanismid, mis on vajalikud pikaajalise hoolduse koordineerimiseks. **Seega peab riik võtma endale suurema vastutuse ja rolli pikaajalise hoolduse juhtimisel ning teenuste planeerimisel ja rahastamisel**, looma ühtse õigusraamistiku, arendama välja analüüsimise mehhanismid pikaajalise hoolduse vajaduste ja teenuste osutamiseks ning tagama tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna parema koordineerituse ja infovahetuse.

Uuringus esitatud stsenaariumid on konstrueeritud vaheetappidena liikumisel olemasolevast olukorrast inimeste jaoks üha tulemuslikuma, kättesaadavama ja võrdsema süsteemi poole. Ideaalse süsteemina inimese (abivajaja ja pereliikme) vaatevinklist on nähtud olukorda, kus põhiosa pikaajalise hoolduse teenustest on rahastatud ja korraldatud avaliku sektori (riik ja omavalitsus) poolt ning pereliikmete roll hoolduse korraldamisel on vähene, piirdudes tavalise abistamise ja madala omaosalusega teenuste rahastamisel. Põhirõhk on kodu- ja kogukonnateenustel, teenuste kättesaadavus on tagatud kõigile ning tervise- ja sotsiaalsektor tegutseb koos-

Tabel 1. Poliitikakujunduse etapid pikaajalise hoolduse arendamiseks

	Hetke- olukord	1. Etapp Parandustega hetkeolukord	2. Etapp Ideaalsema süs- teemi poole	3. Etapp Lähemal ideaal- sele süsteemile
Katvus, kvaliteet, võrdsus	Piiratud	Veidi parem	Möödukas	Suur
Finantskaitse	Minimaalne	Endiselt piiratud	Möödukas	Suur
Eelarvelise jätkusuutlikkuse riskid	Madalad	Madalad	Keskmiised	Kõrged
Mitteametlike hool- dajate koormus	Väga suur	Väga suur	Möödukas	Vähene
Avaliku sektori rahas- tus aastaks 2030	0,6% SKPst	0,6–0,8% SKPst	2%–2,5% SKPst	3,5–4% SKPst
Katteallikad	Eraisikute kulutused	Valdavalt eraisikute kulutused	Eraisikute kulutu- sed, riigi rahastus	Valdavalt riigi rahastus
Rahastus- mehhanismid	Eraldi rahavood	Eraldi rahavood	Koos- ja koostööd toetava rahastuse pilootprojektid	Koos- ja koostööd toetav rahastus
Avaliku sektori teenused	Piiratud	Endiselt piiratud	Laiendatult	Valdavalt
KOvide teenused	Suured erinevused	Kohustuslikud miinimumstandardid	Laiendatud moni- tooring ja analüüs	Universaalne moni- tooring ja analüüs
Inimressursi vajadus	Vähene	Endiselt vähene	Kasvav	Suur
Informatsiooni-vood	Killustatud	Lõimitud visioon	Lõimimise pilootprojektid	Lõimitud
Hüvitiste pakett	Ebapiisav	Endiselt piiratud	Laiendatud	Rikkalik
Sihitamine	Vähene	Tulenevalt inimese majanduslikust olukorrast	Laiem kättesaadavus	Universaalne, vajadusepõhine
Hoolduse lõimitus	Killustatud	Lõimitud visioon	Lõimimise pilootprojektid	Mitmetasandiliselt lõimitud

ALLIKAS: MAAILMAPANK 2007.

kõlastatult. Avaliku sektori rahastus nn ideaalse süsteemi puhul peaks suurenema kuni 3,5–4%-ni SKPst.

See, kui palju raha või tööd otsustab riik pikaajalise hoolduse reformimisse panna ning millise teenuste katvuse tasemeni soovitakse jõuda, sõltub **ühiskondlikest valikutest, poliitilistest otsustest ja maksukoormusest** riigis. Loomulikult ei pea Eesti valima olukorra, kus riik tagab kohe kõigile tee-

nuste kättesaadavuse ning nende täieliku rahastamise, mis ei ole tõenäoliselt realistlik ega jõukohane. Praegusest olukorrast ehk nullpunktist, kus põhikoormus pikaajalise hoolduse korraldamisel kui ka rahastamisel lasub ebaproportsionaalselt pereliikmetel ning vajadus hooldusteenuste järele pidevalt suureneb, tuleb aga edasi liikuda võrdsema ja inimestest hoolivama süsteemi poole. Seetõttu soovitab Maailmapank Eestil edasi

minna samm-sammult, liikudes praegusest olukorrast esimesse etappi ning luues eeldusi pikaajalise hoolduse korralduse järkjärguliseks ülesehitamiseks.

Esimesel etapil jäävad avaliku sektori kulutused suuresti praegusele tasemele (nähes ette siiski teatud lisainvesteeringuid); rõhku pannakse ressursside ümberjaotamisele esmatähtsate vajaduste järgi ning keskvalitsuse juhtimisfunktsiooni tugevdamisele, et osutada tulevikus paremat hooldust. Praegusest olukorrast esimesse etappi liikumiseks on tarvis avaliku sektori piiratud ressursid ümberjaotada nii, et need oleks suunatud piirkondadesse, kus vajadused on kõige suuremad ja kus mitteametlikud hooldajad pakuvad praegu kõige rohkem tuge kõige väiksema hüvitise eest. Teise sammuna tuleb selle etapi tegevuste elluviimiseks panna paika raamistikud, mille põhjal hinnata inimeste teenusevajadust ning jälgida teenuse osutamist ja kvaliteeti kohalikes omavalitsustes. Samuti tuleks kehtestada kohustuslikud teenusestandardid, et tagada üleriigiliselt teenuste võrdne pakkumine ja kvaliteet. Kolmandaks tuleb sellel etapil teha seadusemuudatusi, mida on vaja tervishoiu- ja hoolekandeteenuste koordineerimiseks, sh tervishoiu ja hoolekande infosüsteemide loomiseks. Samuti tuleks teha ettevalmistusi, mis arvestaksid tööjõu vajadust pikaajalises hoolduses tulevikus.

Teisel etapil kasvavad avaliku sektori kulutused mõõdukalt, mis võimaldab suurendada ametlike tervishoiuteenuste katvust, vähendada sõltuvust mitteametlikust hooldusest ning võtta tervishoiu ja hoolekandes kasutusele hoolduse koordineerimise elemente. Teisel etapil rakendatakse täies mahus vajaduste hindamise ja teenuste osutamise järelevalve raamistike, mis võeti kasutusele esimesel etapil. Hoolduse paremaks koordineerimiseks püütakse viia tervishoiu ja hoolekande rahastamine samadele alustele.

Kolmanda etapi puhul kasvavad avaliku sektori kulutused märkimisväärselt, mis läbi paranevad olulisel määral hoolekandeteenuste katvus ja kvaliteet ning inimeste kaitse vaesusriski eest. Kolmanda etapi puhul sarnaneb pikaajalise hoolduse süsteem parimale võimalikule süsteemile, seda eriti Põhjamaades ja mõnes Lääne-Euroopa riigis saavutatud teenustega kõrge katvuse taseme poolest.

Mis saab edasi?

Tuginedes Maailmapanga uuringule ning ekspertide hinnangutele töötas hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm välja raporti poliitikasuunistega pikaajalise hoolduse süsteemi tõhustamiseks ja pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks. Rakkerühma lõppraportis jõuti järeldusele, et hoolduse korraldus vajab süsteemseid muudatusi, sest üles tuleb ehitada **terviklik ja integreeritud pikaajalise hoolduse süsteem**. Uuendatud süsteem peab tagama hooldusvajadusega inimestele ühtlase kättesaadavuse ja kvaliteediga loimitud teenused ning inimesekeskse hoolduse korralduse. Hoolduskoormuse leevendamiseks tuleb kaasata kogukonda ning pakkuda omastehooldajatele suuremat tuge, lähtudes sealjuures põhimõttest, et hooldusvajadusega inimestel on õigus elada täisväärtuslikku ja iseseisvat elu.

Pikaajalise hoolduse reformi õnnestumise tagamiseks on vaja **kindlat vastutajat ja eestvedajat**. Selleks tuleb sotsiaalministeeriumil määrata pikaajalise hoolduse poliitika juhtija, kes on volitatud koordineerima tegevust sotsiaal- ja tervisevaldkonna üleselt ning moodustama meeskonna reformi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Sotsiaalministeeriumi juurde tuleb moodustada ka sidusrühmade esindajatest koosnev tööriühm, kes jälgib reformi elluviimist, annab poliitikakujundajatele nõu ning seisab huvirühmade vajaduste eest. Tööriühma on soovitatav kaasata

hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma liikmeid, kes on kaheaastase protsessi osalisena reformi vajadustest ja eesmärkidest hästi informeeritud. **Teenuste kättesaadavuse ja võrdse kohtlemise** tagamiseks on vaja järkjärgult suurendada avaliku sektori rahastust. Esmajärjekorras tuleb täiendavaid summasid suunata majanduslikult vähemvõimekamatele omavalitsustele, et nad osutaksid pikaajalise hoolduse teenuseid suuremas mahus. Abi ühtlase kvaliteedi ja võrdse kohtlemise tagamiseks on tarvis korrastada õigusruum, välja töötada ühtsed kohustuslikud miinimumnõuded kohaliku omavalitsuse teenustele ning ühtlustada hooldushüvitise maksmise põhimõtted. Inimeste vajaduste ja saadud teenuste kohta tuleb kohalikul tasandil koguda digitaliseeritud andmeid ning inimesekeskse hoolduse korraldamiseks liidestada eri andmebaasid. **Omastehooldajad** jäävad pikaajalise hoolduse süsteemi oluliseks osaks, mistõttu tuleb neile pakkuda suuremat tuge, et vähendada hoolduskoormuse negatiivset mõju hooldajate tervisele ning sotsiaalsele ja majanduslikule toimetulekule. Pereliikme määramine ametlikuks hooldajaks ja selle eest hooldushüvitise maksmine peab olema korraldatud ja rahastatud üleriigiliselt ühtsetel alustel ning paremini sihitatud.

Killustatuse ja dubleerimise vähendamiseks tuleb suurendada **sotsiaal- ja tervisevaldkonna integreeritust**, et parandada inimeste toimetulekut ja pakkuda tulemuslikumat abi. Integreerimine puudutab seadusandlike ja regulatiivsete piirangute vähendamist ja ühtsete eesmärkide sõnastamist, andmete standardiseerimist ja andmetele vastastikku ligipääsu võimaldamist ning teenuste koostööd toetavat rahastamist ja koosrahastamist⁴. Inimese vajadustest

lähtuvate teenuste pakkumiseks ja abi korraldamiseks on vaja pakkuda hooldust **koordineeritult ja inimesekesksetl**. Selleks on esmalt tarvis ühtlustada hooldusvajaduse hindamine, võtta kasutusele standardiseeritud hindamisvahendid ning infotehnoloogia abil kokku viia eri valdkondades ja ametkondades inimese kohta tehtud hindamised. Teisalt tuleb tagada inimesekeskne hoolduse koordineatsioon sotsiaal- ja tervisevaldkonna esmatasandi spetsialistide vahel. Selleks asub sotsiaalministeerium juba 2018. aastal välja töötama hoolduse koordineerimise mudelit.

Pereliikmete hoolduskoormuse vähendamisele saavad kaasa aidata ka **vabatahtlikud ja kogukond**. Avaliku sektori algatusel tuleks luua strateegia vabatahtlike ja kogukonna sihipärasemaks panustamiseks sotsiaalkaitseks ning mudel vabatahtlike kaasamiseks pikaajalisse hooldusesse. Toetada tuleks kogukonnapõhiseid inimeselt-inimesele lahendusi, mis näevad ette omastehooldajate aktiivset osalust kogukonna elus ja toetavad omastehooldajate juba eksisteerivaid kogukondi.

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma lõppraport esitatakse valitsusele arutamiseks aasta lõpus ning seejärel koostab sotsiaalministeerium kui pikaajalise hoolduse poliitika eest vastutaja tegevuskava ja eelarve poliitikasuuniste elluviimiseks. S

Maailmapanga uuringu täisversioon (inglise keeles) ja hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma lõppraport on kättesaadavad Riigikantselei hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma veebilehel <https://riigikantselei.ee/et/hoolduskoormus>.

⁴ Teenuste koostööd toetava ja koosrahastamise all on peetud silmas sotsiaal- ja tervisevaldkonna pikaajalise hoolduse teenuste rahastamise loomimist ja rahavoogude ühtlustamist teenuste efektiivsemaks korraldamiseks ning koostöö suurendamiseks.